No detectamos estrés. Acortamos el camino hasta una persona.

Una app sin servidor para estudiantes de la UPCH. Mide el estrés académico con un instrumento validado en Lima y, sobre todo, deja a un toque el servicio de Bienestar que la universidad ya tiene. No diagnostica y no avisa a nadie: el estudiante decide.

EL PROBLEMA

14,4 %
de los peruanos de 15 a 19 años tuvo un episodio depresivo en el último año.
INEI, ENDES 2023 · grupo de edad, no estudiantes

24 %
de 1 243 universitarios de Piura, en nivel alto de síntomas de ansiedad y depresión.
Valle-Palomino 2024 · nivel de escala, no diagnóstico

15,7 %
de los estudiantes de medicina con síntomas depresivos buscó tratamiento.
Rotenstein 2016, JAMA · mundo

24,6 %
de los universitarios de primer año buscaría tratamiento con seguridad.
Ebert 2019 · 8 países · intención

LA SOLUCIÓN

- **Inventario SISCO**: 31 ítems publicados, validado en 628 universitarios de Lima. Puntaje por subescala, sin niveles inventados.
- **Check-in de 3 toques**: descanso, energía y una pregunta del inventario, tal cual.
- **Tecleo exploratorio**: solo comparado contigo mismo, y rotulado "no mide estrés". El texto nunca se guarda.
- **"Hablar con alguien"** en todas las pantallas, con la Línea 113, opción 5 (MINSA), para una crisis.
- **Mensaje de cambio** con educación sobre el efecto nocebo, en ámbar suave, nunca en rojo de alarma.
- **Pulsito**, una guía que crece con el uso y nunca con las respuestas. Es una hipótesis que se mide, no una promesa de retención.

LA EVIDENCIA QUE NOS CAMBIÓ EL PROYECTO

- Tecleo → estrés entre personas: **ρ = 0,078**, casi azar (Naegelin 2025).
- Apps de salud mental: **3,3 %** sigue usándolas a los 30 días (Baumel 2019). Por eso medimos el puente, no el uso.
- **Predecir ≠ ayudar**: una alerta temprana acertó y el abandono no bajó (Plak 2022).
- Informar sin cuidado sube la autoetiqueta del **28 % al 58 %**; educar sobre el efecto nocebo reduce el aumento a la mitad (Sandra 2025).
- Gamificación: **sin efecto** en la adherencia, en 38 estudios (Six 2021).

Resultado propio, en datos sintéticos: 90/90 con un cambio grande, pero 3/30 con uno tres veces menor. Viabilidad técnica, no validez clínica.

UN PROYECTO PARA TODA CAYETANO PROPUESTO

Psicología	SISCO, protocolo de derivación, lenguaje no patologizante
Salud Pública	Diseño del piloto, tamaño muestral, tiempo hasta la atención
Medicina	Población con más carga; cambio del SISCO en el ciclo
Enfermería	Tópicos como puerta de entrada al puente
Ingeniería	Privacidad en el dispositivo; estabilidad de la señal
Adm. en Salud	Costos, indicadores y sostenibilidad

EL PILOTO PROPUESTO

Indicador principal	Tiempo hasta una consulta efectivamente atendida
También	Conversión a cita, retención real, SISCO pre/post, daño (autoetiquetado), A/B de la mascota en días 1–7
Diseño	Pre/post, intención de tratar, un semestre
Muestra	~250 estudiantes; si el efecto es pequeño, piloto de factibilidad
Datos	Seudonimizados; Bienestar solo ve agregados. Ley 29733 y DS 016-2024-JUS

LO QUE PEDIMOS

Un convenio con Bienestar Estudiantil
Un canal de citas real y la línea base del servicio. Hoy es solo una propuesta.

El comité de ética
Sin su aprobación no hay piloto. El protocolo borrador está listo.

BioIncuba, después del hackathon
Acompañamiento para pasar de prototipo a piloto medido.

Demo: ichisieben.github.io/pulso-upch/demo · **Código:** github.com/IchiSieben/pulso-upch · cada cifra con su fuente en docs/evidencia.md

Uso de IA declarado: Claude (Claude Code) para programar, buscar y verificar fuentes. Revisión y decisiones del equipo.